Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5045268-95.2021.8.21.0001/RS

AUTOR: FELIPE AUGUSTO CECCONELLO DE OLIVEIRA

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

FELIPE AUGUSTO CECCONELLO DE OLIVEIRA ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, alegando possuir diagnóstico de Doença de Crohn grave (CID 10 - K50.1). Refere que, em razão de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento **Ustequinumabe nas dosagens de 130mg e 90mg**, cujo uso deverá ser de forma contínua. Requereu, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento do medicamento pelo réu e, ao final, a procedência do pedido (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 19, DESPADEC1).

Citado, o réu contestou alegando a necessidade de observância do Tema 793-STF, com a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, teceu comentários sobre o artigo 196 da Constituição Federal, os princípios regentes do SUS e a judicialização da saúde, bem como pugnou pela improcedência da demanda (evento 76, CONT1).

Apresentada réplica (evento 80, RÉPLICA1).

Indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda (evento 86, DESPADEC1).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 98, PROMOÇÃO1).

Determinado bloqueio de valores (evento 34, DESPADEC1; evento 101, DESPADEC1; evento 137, DESPADEC1; evento 206, DESPADEC1; evento 271, DESPADEC1; evento 313, DESPADEC1; evento 350, DESPADEC1), a parte autora prestou contas (62.1; 118.1; 154.1; 183.1; 219.1; 233.1; 295.1; 329.1; 369.1), sendo homologadas nos eventos evento 71, DESPADEC1, evento 169, DESPADEC1, evento 192, DESPADEC1, evento 262, DESPADEC1, evento 303, DESPADEC1, evento 339, DESPADEC1e evento 378, DESPADEC1.

Intimada a parte autora para comprovar os requisitos estabelecidos pelas teses fixadas nos Temas 6 e 1234, do STF (evento 398, DESPADEC1).

A parte autora apresentou manifestação no evento 401, PET1 e juntou laudo médico.

Sobreveio nova nota técnica favorável pelo e-NatJus no evento 403, NOTATEC1.

Com vista, o demandado disse que não há interesse na produção de outras provas, não se opondo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. Requereu a aplicação imediata das teses fixadas pelos Temas 1234 e 6 do STF (evento 406, PET1).

E o Ministério Público reportou-se ao parecer de mérito já ofertado no evento 98, PROMOÇÃO1.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

<u>DA COMPETÊNCIA</u>

A questão da competência está superada pela tese fixada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, publicado em 19/09/2024. Segue o trecho do voto relativo à competência, com redação alterada após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina:

> *I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No*

caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

No ponto, houve a modulação de efeitos para aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE, que ocorreu em 19/09/2024:

> *Por fim, modulo os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Ainda sobre a competência, o Ministro Relator, no voto vencedor, que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela União, definiu:

> *3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Na hipótese dos autos, embora o medicamento postulado pelo autor seja incorporado ao SUS no Grupo 1A da RENAME (integrando o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica), é caso de manutenção dos autos na Justiça Estadual, sem determinar a inclusão do ente federal no polo passivo da demanda, considerando que a presente ação foi proposta em 06/05/2021, antes, portanto, da publicação do resultado do julgamento do Tema 1234/STF.

Verifica-se a regularidade do feito, a legitimidade das partes e sua devida representação, sem nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

DO MÉRITO

Direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Do tratamento postulado

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, por meio dos Temas n°s 1234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo reproduzidas:

> *Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> *Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF, estabeleceu-se que:

> *"[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:*
>
> *(...)*
>
> *II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.*
>
> *(...)*
>
> *IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4)* ***Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o*

Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(...)

VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão" [...]" Grifou-se.

No caso dos autos, o medicamento postulado **USTEQUINUMABE** possui registro na registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), no qual decidiu pela recomendação à incorporação ao SUS, para o CID da parte autora, senão vejamos:

Tecnologia Avaliada	Indicação	Relatório Técnico	Relatório para a Sociedade	Recomendação da Conitec Final	Decisão do Ministério da Saúde	Portarias	Data da Publicação
Ustequinumabe	Tratamento de pacientes com Doença Crohn ativa moderadagrave, após falha ao tratamento com uso de antiTNF ou pacientes contraindicados ao uso de antiTNF	Nº 864	Nº 425	Incorporar	Incorporar	SECTICS/MS nº 1/2024	23/01/24

1

Na espécie, o medicamento está incorporado ao SUS por meio da portaria PORTARIA SECTICS/MS Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2024:

PORTARIA SECTICS/MS Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2024

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o ustequinumabe para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.

Ref.: 25000.062446/2023-53.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE - SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso I do art. 32 do Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o ustequinumabe para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646, 21 de dezembro de 2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/conitec/pt-br.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO PINHEIRO SAFATLE

Integrando o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica da RENAME:

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador[1]
ustequinumabe	45 mg/0,5 mL	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn PCDT Psoríase
	130 mg	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn
		pó para		

2

Segundo laudo médico acostado ao feito (evento 401, ATESTMED2), a autora é portadora de Doença de Crohn grave (CID 10 - K50.1), necessitando do uso do medicamento postulado. Ressalta a importância de não interromper o tratamento com o medicamento, tendo em vista que a doença é progressiva e pode levar a uma cirurgia de remoção de parte do intestino.

A Nota Técnica, elaborada pelo e-NatJus, corrobora com a documentação médica, tendo concluído favoravelmente ao fornecimento do medicamento (evento 403, NOTATEC1):

Tecnologia: USTEQUINUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO-SE o diagnóstico de Doença Crohn, segundo dados anexados ao processo.

CONSIDERANDO-SE o quadro de doença perianal operada e perda de respota a Adalimumabe e Azatioprina sendo submetido a terapia de resgate com infliximabe associado a metrotexato, segundo dados de relatório médico anexados ao processo na página 379 datado de 30/01/2023.

CONSIDERANDO-SE que o paciente atualmente se encontra em uso de Ustequinumabe apresentando perda de reposta parcial com necessidade de internação por nova fistula perianal complexa com necessidade de drenagem e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, segundo o mesmo relatório médico.

CONSIDERANDO-SE a possibilidade de reailzação de otimização da terapia com Ustequinumabe a cada 4 semanas para melhora controle da atividade inflamatória e remissão da doença sem necessidade de nova troca de imunobiológico; conduta essa suporta na literatura médica e realizada com certa frequência em casos de perda parcial de resposta.

CONSIDERANDO-SE que há evidência em literatura médico-científica que a terapia com USTEQUINUMABE traz benefícios a pacientes portadores da doença acima, refratários à terapia com as drogas disponíveis no SUS, incluindo Anti-TNF.

CONSIDERANDO-SE a incorporação pela CONITEC do ustequinumabe para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave em Dezembro de 2023.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes, para sustentar a indicação da USTEQUINUMABE em dose otimizada cada 4 semanas no caso em questão em caráter de urgência.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Dessa forma, diante das alegações médicas, da comprovada incapacidade financeira e da portaria de incorporação do medicamento para o diagnóstico da autora, somados aos relatórios favoráveis da CONITEC e do e-NatJus, entendo que restou comprovado o direito alegado, por conseguinte, de rigor, o julgamento de procedência do pleito requerido pela parte autora.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, CPC/15 **JULGO PROCEDENTE** o pedido deduzido por **FELIPE AUGUSTO CECCONELLO DE OLIVEIRA** para determinar ao **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, observada a denominação comum brasileira, em favor da parte autora, conforme prescrição médica ou alcançar os equivalentes em dinheiro, sob pena de ordem de bloqueio de valores em caso de descumprimento, enquanto perdurar a necessidade.

A prescrição médica deverá ser atualizada semestralmente, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde – Farmácia de Medicamentos Especiais ou outro local – pois há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado. **A não atualização do receituário acarretará a <u>suspensão do fornecimento</u> pela Farmácia do Estado até que ocorra a regularização e <u>impedirá a apreciação de eventual pedido de bloqueio de valores</u>**.

Confirmo a tutela de urgência deferida e a gratuidade judiciária.

Custas pelo demandado, ficando isento da Taxa Única de Serviços Judiciais conforme a previsão do art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/14, mas respondendo por eventuais despesas do processo pendentes.

Condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC/2015. O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, com acumulado mensal, uma única vez, para fins de correção e juros de mora, a partir de 09/12/2021, conforme EC 113/2021.

Decisão não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, inc. II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará de eventual saldo em favor do demandado.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido para contrarrazões e, após, independentemente de conclusão, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o art. 1.010, §3º, do CPC.

As partes ficam cientes, desde já, que eventual cumprimento de sentença deve ser manejado em ação autônoma no Sistema EPROC, mas vinculado ao processo da fase de conhecimento, conforme Ofício Circular nº 077/2019-CGJ.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **HERACLITO JOSE DE OLIVEIRA BRITO, Juiz de Direito**, em 24/07/2025, às 15:10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10086293815v24** e o código CRC **8fe996f2**.

---

1. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjA2NjNmMjAtNzU5Yy00YWVkLTk5MjUtYTgxZDEzNDcwOGFjIiwidCI6IjlhNTU0YWQzLWI1MmItNDg2Mi1hMzZmLTg0ZDg5MWU1YzcwNSJ9&utm_source=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fconitec%2Fpt-br&utm_medium=site-conitec-pg-recomendacoes&utm_campaign=Recomenda%C3%A7%C3%B5es+da+Conitec ↩
2. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf ↩